

13 - 04- Purpura thrombopénique idiopathique - Pr. Tazi

Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons entamer par un nouveau chapitre de pathologie hématologique et qui est intitulé le purpurat thrombopénique idiopathique. Nous allons commencer par rappeler que les thrombopénies sont définies par un nombre de plaquettes inférieures à 150 000 par millimètre cube. Elles peuvent être dues à un défaut de production médullaire des plaquettes, c'est ce qu'on appelle les thrombopénies centrales, ou à une anomalie de leur répartition dans le sang au cours par exemple d'un hyperspénisme ou une coagulation intravasculaire disséminée et enfin à leur destruction immunologique par l'intermédiaire de la fixation sur leur membrane de complexe humain, c'est ce qu'on appelle les thrombopénies périphériques.

Donc le purpurat thrombopénique immunologique PTI est la plus fréquente des cytopénies auto-immunes. Il est dû à des autres anticorps reconnaissant des déterminants antigéniques de la membrane plaquettaire qui, lorsqu'elles vont se fixer sur cette membrane plaquettaire, vont entraîner leur destruction par le système des phagocytes mononucléaires, en particulier spleeniques. Donc on va parler du PTI que lorsque toutes les étiologies ont été écartées, donc le PTI c'est un diagnostic d'élimination.

L'incidence de cette maladie est estimée à 100 cas par million d'habitants, les formes de l'enfant sont le plus souvent aigus et intéressent aussi bien les garçons que les filles, alors que les formes de l'adulte sont le plus souvent chroniques et touchent plus souvent les femmes que les hommes. Donc la nouvelle terminologie de classification du PTI, le comité international a proposé une nouvelle terminologie et de nouveaux critères diagnostiques du PTI. Il est ainsi proposé de classer le PTI en trois périodes.

Entre le diagnostic et le troisième mois de la maladie, le PTI est considéré comme nouvellement diagnostiqué. Entre le troisième mois et la première année suivant la période du diagnostic, le PTI est classé comme persistant et après une année d'évolution, le PTI est défini comme chronique. Alors, pour comprendre un petit peu la physiopathologie, la thrombopoïèse est l'ensemble des étapes intramédullaires par lesquelles une cellule myéloïde se transforme en mégakaryocytes puis en plaquettes par la fragmentation cytoplasmique de celui-ci.

L'hormone qui régule la thrombopoïèse est la thrombopoéthine qui est synthétisée par le poids et le rôle. Les plaquettes sont des éléments anucléés de 3 micromètres de diamètre, leur durée de vie est entre 7 à 10 jours et leur destruction s'effectue principalement dans la rate et dans le foie. Leur fonction principale, c'est d'assurer une bonne hémostasie primaire.

Donc, la thrombopénie observée au cours du PTI résulte de la fixation sur la membrane plaquettaire d'immunoglobuline, le plus souvent d'isotype G, qui altère et induit sa destruction par le système des phagocytes mononucléés, en particulier spleeniques. La raison exacte de l'apparition de ces auto-anticorps anti-plaquettes est inconnue. L'hypothèse la plus souvent

avancée est celle d'une dérégulation du réseau de idiotypies.

Quelles sont les circonstances de découverte? Donc, la thrombopénie peut être découverte à l'occasion d'un hémogramme systématique alors que le patient est asymptomatique ou bien présente un syndrome hémorragique discret. Donc, il peut être également révélé par un syndrome hémorragique de type purpuracutanée, pétéchiale ou équimotique prédominant aux membres inférieurs, des hématomes de petite taille localisés aux membres et aux zones de pression. Il peut être aussi plus sévère et alors extériorisé et caractérisé par des hématomes spontanés expansifs disséminés sur tout le corps, des bulles hémorragiques buccales, des saignements muqueux comme des épistaxis, des gingivorragies ou bien des mélométroragies.

Donc, à réflexe, il faut toujours regarder dans la bouche d'un patient thrombopénique à la recherche de bulles hémorragiques buccales. Le PTI peut aussi se manifester également lors d'hémorragies viscérales graves, notamment digestives, cérébro-mélangées et rétinienne. Donc, je répète qu'il faut rechercher systématiquement les signes de gravité d'un PTI qui sont le purpuranoirac nécrotique, les bulles hémorragiques muqueuses et les hémorragies rétinienne qu'il faut rechercher au fond de l'œil.

Sur le plan paraclinique, en l'absence de signes hémorragiques ou lorsque ceux-ci sont discrets alors que la thrombopénie est sévère, il faut d'abord confirmer la réalité de cette thrombopénie en vérifiant l'absence d'agglutination des plaquettes in vitro entraînant une erreur de compte par l'appareil automatique. Cette fausse thrombopénie est secondaire à la présence d'un anticorps anti-plaquette actif uniquement en présence de TTA anticoagulant utilisé dans les tubes de prélèvement. Ce diagnostic peut être suspecté par l'analyse du protisanguin qui révèle la présence d'agglutinat de plaquettes.

Il est confirmé par la normalité du compte de plaquettes lorsque celui-ci est effectué sur un prélèvement capillaire ou sur un sang prélevé avec un autre anticoagulant comme la citrate. Donc l'hémogramme va objectiver une thrombopénie qui est souvent sévère, inférieure à 20 000 par mL, un volume moyen plaquettaire augmenté supérieur à 10 qui va témoigner de la thrombopénie périphérique. L'hémoglobine est normale ou bien elle peut être diminuée lorsqu'il y a un saignement abondant et le chiffre des globules blancs est généralement normal.

La réalisation d'un mylogramme permet d'affirmer la nature périphérique de la thrombopénie et éliminer une thrombopénie qui est centrale. Il est de richesse normale avec une augmentation de la richesse en mégakaryocyte, c'est-à-dire que la moelle est toujours productive. La réalisation d'un bilan des moustaches est aussi indispensable pour éliminer certains diagnostics différentiels, en particulier les coagulopathies de consommation.

Donc le bilan des moustaches est tout à fait normal. La recherche d'anticorps anti-plaquettes n'est pas nécessaire aux diagnostics qu'elle peut être utile lorsqu'il y a un doute diagnostique, car la découverte d'anticorps anti-plaquettes est un argument supplémentaire mais non absolu en

faveur du mécanisme immunologique de la thrombopénie. Par contre, l'étude de la durée de vie des plaquettes, c'est-à-dire l'étude isotopique des plaquettes est exceptionnellement pratiquée à visée diagnostique.

Elle met en évidence un raccourcissement de la durée de vie des plaquettes, d'où son caractère périphérique. Elle montre aussi le siège de cette destruction des plaquettes, ce qui a l'intérêt dans l'indication de la splénectomie chez les patients résistants aux corticoïdes. Concernant le diagnostic différentiel, il se pose avec la thrombopénie d'origine centrale qui est facilement éliminée devant l'absence d'anomalies des autres lignées sanguines et sur les données du myélogramme et les autres thrombopénies périphériques.

Donc, les principales pathologies qu'il faudra éliminer, c'est surtout la CIVD ou la coagulation cravasculaire disséminée. Le contexte clinique et théologique ainsi que la perturbation du bilan des moustaches est évident, donc le diagnostic de CIVD est généralement facile à poser. L'autre diagnostic différentiel, c'est l'hypertension portale où on observe une splénomégalie volumineuse et autres signes d'hypersplénisme.

La plasmie médullaire où on a un syndrome d'insuffisance médullaire associant un syndrome anémique à un syndrome hémorragique et un syndrome infectieux et à l'annumération on observe une pancytopénie. La leucémie aiguë peut aussi poser un problème de diagnostic différentiel en cas de syndrome d'insuffisance médullaire associant un syndrome tumoral et à l'annumération on observe une blastose sanguine et là aussi le myélogramme permet en principe facilement de poser le diagnostic. Quand on arrive maintenant au diagnostic étiologique de la thrombopénie, il est toujours indispensable d'analyser de manière exhaustive les médicaments reçus dans les semaines qui ont précédé l'installation de la thrombopénie, même en cas de prise unique de ce médicament.

Il faut rechercher aussi la présence de comportements à risque pour l'infection par le VIH, une maladie de transfusion récente orientée vers un diagnostic de purpura post-transfusionnelle, un syndrome glycémique aussi à rechercher dans les semaines précédentes et l'interrogatoire s'acharnera aussi à rechercher des signes orientant vers une connectivite ou un syndrome des antiphospholipides comme des arthralgies, une faiblesse de sensibilité, un syndrome de Raynaud, des fausses couches spontanées répétées, une anorexie, bien des fluides récidivants. Et concernant l'examen clinique, en principe il est pauvre en dehors d'un éventuel syndrome hémorragique dont il faut apprécier l'importance et des signes d'anémie qui ont traduit la sévérité. Donc le PTI est un diagnostic d'élimination.

Aucun texte ne permet d'en affirmer le diagnostic. Donc aucun texte ne permet d'affirmer le diagnostic de PTI. Ça n'existe pas.

Donc le diagnostic de certitude repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et éventuellement radiologiques. Donc retenir, le PTI c'est un diagnostic d'élimination. Donc on

retient ce diagnostic qu'après avoir éliminé toutes les causes de thrombopénie.

Le traitement du purpurachrombopénique idiopathique doit de préférence être confié au médecin spécialiste mais parfois le médecin généraliste peut prendre en charge les formes faciles de ce PTI. Alors d'abord quelles sont les mesures symptomatiques qu'il faut préconiser? Il est indispensable de se reposer pendant la phase aiguë. Donc le repos au lit pendant la phase aiguë est impératif.

Il faut éviter les gestes invasifs, les sports violents, les traitements modifiants, les moustaches comme l'aspirine et interdire les injections intramusculaires. Il faut aussi préconiser la contraception orale continue pour les femmes en période d'activité génitale afin d'obtenir une améliorée. Et comment est-ce qu'on va traiter le PTI? Le traitement de première intention c'est la corticothérapie.

On donne en général de la prise d'isone à raison de 1 mg par kilo par jour pendant 3 semaines puis d'agression rapide avec un arrêt à la cinquième semaine. Elle doit être accompagnée d'une supplémentation en potassium, en calcium, un régime sans sel et un régime sans sucre. Donc pourquoi est-ce qu'on fait cette supplémentation? Donc généralement parmi les effets indésirables des corticoïdes c'est l'hypertension artérielle et le diabète cortico-induit.

Donc c'est pour ça qu'on demande aux malades de ne pas prendre de sel ou de sucre au cours du traitement par les corticoïdes. Donc en principe une ascension du chiffre des plaquettes est observée au cours de la première semaine. Il faut donc sur le plan biologique surveiller le poids, la glycémie et également la prise quotidienne de la tension artérielle.

Parmi les autres thérapeutiques ou bien traitements de deuxième ligne il y a les immunoglobulines polyvalentes par voie intraveineuse qui sont indiquées en seconde intention en cas d'échec aux corticoïdes et surtout en cas d'urgence. Par exemple si le malade présente une hémorragie aiguë ou bien une préparation à l'insulinectomie ou bien lors d'un acte invasif, pour avoir une ascension rapide du chiffre des plaquettes il vaut mieux injecter ces immunoglobulines polyvalentes. Donc le mécanisme d'action c'est une saturation des sites macrophagiques des anticorps permettant ainsi aux plaquettes de rester en circulation malgré l'attaque préalable par les anticorps.

Donc la dose requise c'est de 1 gramme par kilo par jour 2 jours de suite. Elle permet une augmentation des plaquettes dès le premier jour avec une normalisation du chiffre à J3 au troisième jour dans presque la majorité des cas sur une durée de 3 semaines et cette réponse aux immunoglobulines elle est transitoire. Donc leur utilisation est limitée en raison de leur coût élevé.

Les autres thérapeutiques proposées en deuxième ou en troisième lieu c'est la splénectomie. Donc son indication doit être posée dans un milieu spécialisé après 12 mois d'évolution du PTI. Elle est efficace dans 60% des cas donc c'est un traitement de deuxième intention.

Elle doit être précédée par un vaccin anti pneumocoque comme le pneumo 23 14 jours avant et un antihémophilus influenzae et suivi d'un traitement préventif par la pelliculine V. Donc on administre ou bien on donne au malade l'oraciline 1 million 2 fois par jour par voie orale pendant au moins une durée de 3 ans. Parmi les autres thérapeutiques il y a le rituximab. C'est un anticorps monoclonal antisédélin utilisé en perfusion hebdomadaire pendant 4 semaines qui permet aussi d'obtenir un taux de réponse de 60%.

Il existe aussi d'autres thérapeutiques qui relèvent du spécialiste comme le danazole ou bien le cyclophosphamide. Important, la transfusion de plaquettes n'a pas d'effet sur la correction de la thrombopénie puisque les plaquettes transfusées sont rapidement détruites. Donc la transfusion de plaquettes ne trouve pas sa place dans le PTI que face à un syndrome hémorragique grave qui va menacer le pronostic vital.

Ce qu'il faut retenir de ce cours c'est que le purpurat thrombopénique immunologique est la cause la plus fréquente des thrombopénies périphériques immunologiques et le PTI, c'est-à-dire le purpurat thrombopénique idiopathique, c'est un diagnostic d'élimination. La thrombopénie résulte d'une destruction des plaquettes revêtues d'anticorps par le système monocytomacrophagique du foie et de la rate et la principale manifestation du PTI c'est le saignement cutaneo-muqueux. Les hémorragies sévères, en particulier cérébro-ménagées, sont rares et le diagnostic est basé sur l'hémogramme révélant une thrombopénie et un biogramme normal, un bilan d'hémostase normal, un bilan auto-humain négatif.

Donc le PTI c'est un diagnostic d'élimination. Il faut réaliser un ensemble de bilans biologiques, en NFS, myélogramme, bilan d'hémostase et au moins un bilan auto-humain pour s'assurer de la négativité de ce diagnostic. Donc le traitement de première intention du PTI repose sur la corticothérapie et en cas d'échec de cette corticothérapie, un traitement de deuxième intention est indiqué.

Il repose le plus souvent sur la splénectomie et ou bien le rifampicine. Les immunoglobulines intraveineuses sont surtout indiquées en cas de situation d'urgence.